

Tous les QCM

1. *Concernant les fonctions oropharyngées, la réponse suivante est **incorrecte** :
 - a. Conduit de passage de l'air ou des aliments
 - b. Contribue à la phase pharyngée de la déglutition
 - c. Assure une défense locale et une immunité contre les intrus nuisibles dans les voies respiratoires et alimentaires
 - d. Fait partie du conduit vocal pour certains sons de la parole
 - e. Contribue à l'appréciation des odeurs**
2. *La cause la plus fréquente de paralysie bilatérale du nerf laryngé récurrent est a. Un traumatisme laryngé b. Une lésion **iatrogène chirurgicale en cas de thyroïdectomie totale** c. Une masse tumorale s'étendant dans la partie supérieure du médiastin d. Polyneuropathie toxique des nerfs laryngés récurrents e. Laryngite sous-glottique aiguë
3. *Le symptôme le plus important de l'otospongiose est
 - a. Vertige
 - b. Perte auditive de transmission**
 - c. Perte auditive neurosensorielle
 - d. Plénitude auditive
 - e. Acouphènes
4. *Le traitement électif du cholestéatome est
 - a. Antibiothérapie
 - b. Chimiothérapie
 - c. Radiothérapie
 - d. Chirurgie**
 - e. Politique d'attente et de scanner
5. *La cloison nasale divise le nez en a. Fosse nasale supérieure et inférieure b. Fosse nasale **droite et gauche** c. Fosse nasale latérale et médiale d. Quatre cavités 2 supérieures et 2 inférieures e. Quatre cavités, 2 médiales et 2 latérales
6. *Sinus maxillaire
 - a. S'ouvre dans la partie postérieure de l'infundibulum ethmoïdal dans le méat moyen.**
 - b. S'ouvre dans le méat supérieur.
 - c. Son innervation provient du NC IX.
 - d. C'est le plus petit sinus
 - e. A une capacité de 5 ml
7. Les relations du méat acoustique externe sont
 - a. Supérieurement – fosse crânienne moyenne**
 - b. Postérieurement – cellule aérienne mastoïdienne et nerf facial**
 - c. Inférieurement – glande parotide**
 - d. Antérieurement – articulation temporo-mandibulaire**
 - e. Supérieurement – cellules aériennes mastoïdiennes et nerf facial
8. La trompe d'Eustache (pharyngo-tympanique) a. Relie la cavité tympanique au nasopharynx **b. Partie osseuse – 1/3 lat.** c. Partie fibrocartilagineuse – 2/3 médial d. Torus tubaris à l'extrémité pharyngée e. Cellules zygomatiques dans la partie médiane

9. Les osselets de l'oreille moyenne sont

a. Marteau

b. Tenseur du tympan c.

Enclume

d. Étrier e.

Stapedius 10. Les

facteurs prédisposant à l'otite moyenne aiguë suppurée sont

a. Crises récurrentes de rhume, d'infections des voies respiratoires supérieures et de fièvre exanthématique b. Infections des amygdales et des végétations adénoïdes

c. Tympanosclérose chronique d.

Allergie nasale e.

Tumeurs du nasopharynx, tamponnement du nez ou du nasopharynx pour épistaxis 11. Les signes

de mastoïdite aiguë sont a. Sensibilité

mastoïdienne

b. Écoulement auriculaire : écoulements mucopurulents ou purulents c. Affaissement

de la paroi inférieure d. Gonflement au-

dessus de la mastoïde e. Perte auditive – type

de transmission 12. Les symptômes de l'otospongiose

sont a. Perte auditive – type neurosensoriel

bilatéral b. Paracusis willisii – le patient entend mieux dans un

environnement bruyant que dans un environnement calme c. Acouphènes

d. Vertige e.

Parole douce, monotone et bien modulée

13. Diagnostic différentiel de l'otospongiose a. Otite

moyenne séreuse

b. Tympanosclérose c.

Fixation attique de la tête du marteau

d. Neurinome de l'acoustique

e. Discontinuité ossiculaire 14. Les

principaux symptômes de la maladie de Ménière sont a.

Vertiges épisodiques b.

Paracusis willisii

c. Perte auditive fluctuante d.

Acouphènes

e. Sensation de plénitude dans l'oreille concernée

15. Innervation du larynx

a. Moteur : nerf laryngé récurrent b. Sensitif : nerf

laryngé interne (au-dessus de la corde vocale)

c. Moteur : nerf laryngé récurrent (sous la corde vocale)

d. Moteur : nerf laryngé récurrent (au-dessus de la corde vocale)

e. Sensoriel : nerf laryngé récurrent (sous la corde vocale)

16. Traitement de la laryngite hyperémique chronique

a. Élimination de l'infection des voies respiratoires supérieures ou inférieures b.

Évitement des facteurs irritants c. Chirurgie

d. Repos de la voix et orthophonie e.

Expectorants

17. Les lésions congénitales du larynx sont a.

Laryngomalacie b.

Hémangiome sous-glottique c. Fente

laryngo-œsophagienne

d. Pectus excavatum

e. Larynx 18. Traitement

de la cordite polypoïde (œdème de Reineke) a. Arrêt du tabac b.

Chirurgie : cordectomie c.

Médicaments antireflux d.

Thérapie vocale préopératoire

e. Chirurgie : stripping des cordes

vocales 19. Les tumeurs bénignes du

larynx sont a. Carcinome épidermoïde b.

Chondrome

c. Hémangiome d.

Tumeur à cellules granuleuses

e. Tumeur glandulaire 20.

Étiologie du cancer du larynx a. Tabac,

alcool b. Traumatisme cervical

c. Radiation antérieure

d. Facteurs génétiques

e. Exposition professionnelle 21.

Les symptômes du cancer de la glotte sont

a. L'enrouement est un symptôme précoce b.

L'enrouement est un symptôme tardif c.

Stridor et obstruction laryngée aux stades avancés d. Stridor et

obstruction laryngée aux stades précoces e. Mal de gorge 22.

Types de

cordectomies a. type I - une

cordectomie sous-épithéliale, qui est une résection de l'épithélium ;

b. type II - une cordectomie sous-ligamentaire, qui est une résection de l'épithélium, de l'espace de Reinke et de la voix ligament;

c. type III - cordectomie transmusculaire, qui passe par le muscle vocalis ;

d. type IV - cordectomie totale ;

e. type Va - cordectomie étendue, qui englobe la corde vocale controlatérale et la corde vocale antérieure commissure;

f. type Vb - cordectomie étendue, qui inclut l'aryténoïde ;

g. type Vc - cordectomie étendue, qui englobe la sous-glotte ;

h. type Vd - cordectomie étendue, qui inclut le ventricule.

23. Les indications de la trachéotomie sont

a. Obstruction respiratoire b.

Sécrétions retenues

c. Insuffisance respiratoire d.

Pubérophonie

e. Enrouement

24. Les types de trachéotomie sont

a. Trachéotomie haute ; au-dessus du niveau de l'isthme thyroïdien b.

Trachéotomie haute : à travers les anneaux II et III

c. Trachéotomie moyenne : à travers les anneaux II et III d.

Trachéotomie moyenne : sous le niveau de l'isthme thyroïdien e.

Trachéotomie basse : sous le niveau de l'isthme thyroïdien

25. Les drains du sinus frontal

a. Dans le méat supérieur b. Dans

le récessus frontal (55 %)

c. Au-dessus mais pas dans l'infundibulum (30 %)

d. Dans l'infundibulum (15 %)

e. Au-dessus de la bulle ethmoïdale

26. Les fonctions des sinus paranasaux sont

a. Climatisation de l'air inspiré : réchauffement et humidification b. Résonance vocale

c. Isolants thermiques – protection des structures délicates de l'orbite et du crâne d. Drainage nasal e. Allègement des os du crâne

27. Les caractéristiques cliniques de la sinusite maxillaire aiguë sont

a. Symptômes constitutionnels : fièvre, malaise général b. Maux de tête

c. Douleur – sur la mâchoire supérieure, parfois dans la région supra-orbitaire ipsilatérale d. Sensibilité (la pression sur la paroi antérieure de l'antre produit de la douleur e. Écoulement post-

nasal (pus sur le palais dur lors de la rhinoscopie antérieure)

28. Les complications de la sinusite maxillaire aiguë sont

a. Infection profonde du cou b.

Sinusite subaiguë ou chronique c. Ostéite

ou ostéomyélite d. Cellulite ou abcès

orbitaire, névrite optique e. Thrombose du sinus caverneux

29. Les caractéristiques cliniques de la sinusite ethmoïdale aiguë sont

a. Douleur sur l'arête du nez, médiale et profonde par rapport à l'arcade sourcilière ; aggravée par le mouvement

b. Œdème des paupières

c. Enrouement

d. Écoulement nasal

e. Gonflement du cornet 30. L'anneau

de Waldeyer est constitué de a. Amygdale

nasopharyngée ou végétations adénoïdes b. Amygdales

palatines

c. Amygdales linguales

d. Amygdales gastriques

e. Amygdales mastoïdiennes

f. Amygdales tubaires (dans la fosse de Rosenmüller)

31. L'hypopharynx se subdivise cliniquement en trois régions

a. Le sinus piriforme (fosse) se situe de chaque côté du larynx et se développe à partir du pli pharyngo-épiglottique...

extrémité de l'œsophage

b. Région postcricoïde : la partie de la paroi antérieure du laryngopharynx située entre les parois supérieure et inférieure

bords de la lame cricoïde

c. Paroi pharyngée postérieure : s'étend du niveau de l'os hyoïde au niveau du cricoaryténoïde d. Corde vocale

e. Pli ventriculaire

32. *Les fonctions de l'hypopharynx sont

a. Conduit de passage de l'air ou des aliments b.

Respiration c.

Aide à la phase pharyngée de la déglutition d. Climatisation

de l'air inspiré : réchauffement et humidification e. Fait partie du conduit vocal pour certains sons de la parole

33. Les complications de l'abcès périamygdalien (angine) sont

- a. Abscès parapharyngé b. Œdème du larynx c. Septicémie
- d. Pneumopathie

e. Hémorragie spontanée de la veine carotide ou de l'artère jugulaire 34. Sur la paroi

latérale des fosses nasales, on trouve a. Le méat moyen b. La cloison

nasale c. Le méat inférieur d.

L'ostium du sinus maxillaire

e. Les végétations adénoïdes

35. La déviation de la cloison nasale peut entraîner

a. Sinusite b.

Respiration orale c. Hypo-/
ansomie

36. * Concernant l'anatomie du pharynx, laquelle des affirmations suivantes est **incorrecte** :

- a) Il s'étend de la base du crâne jusqu'au bord inférieur du cartilage cricoïde en avant et au bord inférieur de C6 en arrière
- b) La partie la plus large (5 cm) se situe au niveau de l'hyoïde
- c) La partie la plus étroite (1,5 cm) se trouve à son extrémité caudale
- d) Le pharynx est divisé en 3 parties : naso-/oro- et laryngopharynx
- e) Le pharynx mesure plus de 20 cm de longueur

37. Les structures de la paroi pharyngée sont les suivantes, à une exception près. Indiquer l'**exception** :

- a) Muqueuse
- b) Aponévrose pharyngée
- c) Fascia musculaire
- d) Fascia bucco-pharyngé
- e) Périoste

38. L'anneau de Waldeyer est composé des éléments suivants **sauf un**

a. Glandes sous-maxillaires b.

Amygdales nasopharyngées ou végétations adénoïdes

c. Amygdales palatines

d. Amygdales tubaires (dans la fosse de Rosenmüller)

e. Nodules (sur la paroi post-pharyngée)

39. *Les fonctions nasopharyngées sont les suivantes **sauf une**

- a. Conduit pour l'air
- b. Ventile l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache
- c. Résonance
- d. Passage pour les aliments et les liquides
- e. Canal de drainage 40.

Les symptômes de l'adénoïte auriculaire sont

- a. Obstruction tubaire
- b. Sinusite
- c. Crises récurrentes d'otite moyenne aiguë
- d. Écoulement nasal e. Otite moyenne séreuse

41. Concernant l'angiofibrome nasopharyngé juvénile, les affirmations suivantes sont **correctes**

- a. Cause exacte inconnue
- b. Âge et sexe (exclusivement chez les hommes dans la tranche d'âge 40-60 ans)
- c. Se manifeste par une obstruction nasale progressive et un langage nasal
- d. La biopsie est associée à un saignement profond et doit donc être évitée
- e. Le traitement est toujours chirurgical

42. Concernant le cancer du nasopharynx, les affirmations suivantes sont **correctes**

- a. Début à l'âge : de la 5e à la 7e décennie, mais peut concerner des groupes d'âge plus jeunes.
- b. Les métastases ganglionnaires cervicales peuvent être la seule manifestation.
- c. Les symptômes et signes otologiques sont représentés par une surdité de transmission, séreuse et suppurée. otite moyenne
- d. Les symptômes ophtalmo-neurologiques sont toujours présents au début
- e. Les métastases à distance se trouvent dans la trompe d'Eustache

43. Lesquels des symptômes suivants sont des symptômes d'amygdalite aiguë ?

- a. Mal de gorge
- b. Difficulté à avaler
- c. Respiration buccale
- d. Fièvre
- e. Mal d'oreille

44. Lesquelles des complications suivantes sont des complications de l'amygdalite aiguë ?

- a. Strabisme convergent
- b. Rhumatisme articulaire aigu
- c. Amygdalite chronique
- d. Glomérulonéphrite aiguë
- e. Endocardite bactérienne subaiguë

45. La DD d'une amygdalite aiguë est réalisée avec a.

- a. Amygdalite membraneuse
- b. Diphtérie
- c. Rhinite
- d. Angine de Vincent
- e. Infections mononucléose

46. La DD de l'amygdalite aiguë est réalisée avec

- a. Sinusite
- b. Manifestations bucco-pharyngées dans l'agranulocytose
- c. Manifestations bucco-pharyngées dans la leucémie
- d. Ulcères aphteux
- e. Tumeur maligne de l'amygdale

47. Concernant la tumeur maligne de l'hypopharynx, lesquelles des affirmations suivantes sont **correctes** ?

- a. Les signes cliniques sont représentés par une dysphagie progressive, une malnutrition, une perte de poids, une modification de la voix et une dysphonie
- b. L'examen au miroir peut ne pas être utile
- c. Le site d'origine le plus fréquent est la région sous-glottique
- d. Le pronostic est mauvais
- e. Chirurgie, radiothérapie et thérapie combinée

(12-20) qui traversent la lame criblée et se terminent dans la

- a. Lobe frontal
- b. Lobe temporal
- c. Lobe olfactif
- d. Lobe pariétal
- e. Bulbe olfactif

49. Le rinophyma est a . Une

- a. masse bénigne à croissance lente
- b. Une tumeur maligne à croissance lente
- c. Il s'agit d'une hypertrophie des glandes sébacées de la pointe du nez.
- d. Elle est traitée par excision chirurgicale ou par laser CO2.
- e. Apparaît en raison de l'hypertrophie des glandes sudoripares du bout du nez

50. L'atrésie des choanes

- a. Peut être uni-, bilatéral, complet, incomplet, osseux (90 %) ou membraneux (10 %)
- b. Elle est toujours bilatérale, complète, osseuse ou membraneuse. c. Il s'agit d'une urgence en cas d'atrésie choanale bilatérale. d. L'un des signes diagnostiques est l'absence de bulles d'air dans l'écoulement nasal. e. L'impossibilité de passer un cathéter du nez au pharynx est un signe diagnostique important.

51. *Un kyste dermoïde est

- a. Une tumeur maligne b. Une tumeur congénitale c. Une infection d. Une collecte de sang e. Signe de consommation 52.

*Dans le méat moyen, ouvrez les sinus suivants a. Sinus ethmoïdaux

- maxillaires, frontaux et antérieurs b. Sinus ethmoïdaux postérieurs c. Sinus sphénoïdal d. Sinus caverneux e. Sinus tympanique

53. Hématome septal

- a. Accumulation de sang sous le périchondre ou le périoste de la cloison nasale. b. Elle peut être causée par un traumatisme nasal ou une intervention chirurgicale. c. Le traitement consiste en une aspiration à l'aide d'une aiguille stérile de gros calibre. d. Incision et drainage des hémorragies plus importantes par méchage nasal bilatéral. e. Accumulation de tissu conjonctif.

54. Peau nasale, quelles affirmations sont **correctes** ?

- a. Peau fine et librement mobile, recouvrant les os du nez b. Peau fine avec de nombreuses glandes sébacées, recouvrant l'os du nez et les cartilages latéraux inférieurs c. Peau épaisse, adhérente et riche en glandes sébacées recouvrant les cartilages alaires d. Peau fine et adhérente recouvrant les cartilages alaires e. Peau épaisse avec de nombreuses glandes sébacées, recouvrant l'os du nez et les cartilages latéraux supérieurs 55. Rhinosclérome

- a. L'étiologie est un bacille Gram négatif – Klebsiella Rhinoscleromatis b. L'étiologie est un Gram positif – Staphylococcus aureus c. Les stades cliniques sont : atrophique, granulomateux, cicatriciel d. Un diagnostic certain est posé par biopsie e. Traité par streptomycine et tétracycline 56. Traitement de la rhinite allergique : les éléments suivants sont **corrects** : a. Éviter

l'allergène b. Surexposition à l'allergène c. Antihistaminiques

- d. Corticostéroïdes (oraux et topiques) e. Radiothérapie 57.

Les symptômes de la rhinite vasomotrice sont a.

- Respiration sifflante b. Rhinorrhée excessive c. Obstruction nasale d. Écoulement post-nasal e. Toux

58. Les causes locales d'épistaxis sont a.

- Un traumatisme / un corps étranger
- b. Infections
- c. Tumeurs du nez et des sinus paranasaux
- d. Chaleur
- e. Froid

59. Épistaxis postérieure

- a. Provient principalement de la partie postéro-supérieure de la fosse nasale b.
- Survient spontanément, souvent en raison d'une hypertension ou d'une artériosclérose c.
- La cause la plus fréquente est un traumatisme
- d. Survient principalement chez les enfants ou les jeunes adultes e. Légère et facile à contrôler

60. Complications de la sinusite frontale a.

- Cellulite orbitaire b.
- Ostéomyélite de l'os frontal c. Méningite,
- abcès extradural ou abcès du lobe frontal
- d. Nécrose du sinus maxillaire e.
- Conjonctivite aiguë

61. Affirmation correcte concernant la laryngomalacie a.

- Anomalie laryngée congénitale la plus courante (50-75 %)
- b. Cause la plus fréquente de stridor chez l'adulte c.
- Prédominance masculine 2:1
- d. Flaccidité du tissu laryngé supraglottique
- e. Caractérisé par un affaissement vers l'intérieur des structures du

pharynx 62. Les hémangiomes sous-

- glottiques sont a. Asymptomatiques
- jusqu'à 12 mois b. 50 % ont des hémangiomes cutanés associés
- c. Stridor mais un cri normal d.
- Masse bleu-rougeâtre sous les cordes vocales
- e. Biopsie – fortement indiquée

63. *L'épiglotte est formée par

- a. Muscle
- b. Os
- c. Cartilage fibreux d.
- Tissu adipeux e. Peau

64. *La cause la plus fréquente de paralysie bilatérale du nerf laryngé récurrent est a. Un traumatisme laryngé b.

- Une lésion iatrogène chirurgicale en cas de thyroïdectomie totale due à un carcinome de la glande thyroïde c. Une
- masse tumorale s'étendant dans la partie supérieure du médiastin d. Une
- polyneuropathie toxique des nerfs laryngés récurrents e. Une laryngite
- sous-glottique aiguë

65. Les fonctions du larynx sont

- a. Phonation
- b. Respiration c.
- Protection des voies respiratoires inférieures d.
- Fixation thoracique
- e. Expectoration

66. Voici les lésions intracrâniennes de l'otite moyenne : a. Abscès

extradural

b. Pétrosite

c. Méningite D.

Labyrinthite e. Abscès

cérébral

67. Les abcès liés à une infection mastoïdienne sont

a. Abscès post-auriculaire b.

Abscès zygomatique c.

Abscès de Bezold

d. Pétrosite

e. Cellulite orbitaire

68. Les symptômes de l'adénoïdite auriculaire **ne sont pas** :

a. Obstruction tubaire

b. Sinusite

c. Crises récurrentes d'otite moyenne aiguë

d. Écoulement nasal

e. Otite moyenne séreuse#

69. *L'épiglotte est formée par

a. Muscle

b. Os

c. Cartilage fibreux

d. Tissu adipeux

e. Peau

70. Lesquelles des affirmations suivantes sont **correctes** :

a. Dans le test de Weber, le diapason est placé sur le processus mastoïde

b. Dans le test de Weber, un patient ayant une audition normale localise le son soit au centre de la tête, soit

également dans les deux oreilles

c. Dans le test de Weber, un patient souffrant d'une perte auditive de transmission unilatérale localise le son dans l'oreille affectée

d. Dans le test de Weber, un patient souffrant d'une perte auditive neurosensorielle localise le son dans l'oreille affectée

e. Dans le test de Weber, un patient souffrant d'une perte auditive neurosensorielle localise le son dans l'oreille saine

71. Le diagnostic différentiel de l'amygdalite aiguë est réalisé avec

a. Ulcères apthiques

b. Tumeur maligne de l'amygdale

c. Sinusite

d. Manifestations buccopharyngées dans l'agranulocytose

e. Manifestations buccopharyngées dans la leucémie

72. L'otospongiose est caractérisée par a.

Une altération de la fonction de la trompe d'Eustache

b. Acouphènes

c. Hyalinisation et calcification du tissu conjonctif sous-épithélial, dépôts crayeux blancs dans le promontoire et osselets

d. Perte auditive de transmission

e. Paracusis willisii

73. La laryngite chronique non spécifique **ne peut PAS être** :

a. Catarale

b. Causé par tbc

c. Type hypertrophique rouge et blanc

d. Atrophique

e. Causée par la syphilis

74. L'anneau de Waldeyer n'est PAS composé des éléments suivants :

- a. Amygdale nasopharyngée ou végétations adénoïdes
- b. Amygdales palatines
- c. Amygdales linguales
- d. Amygdales gastriques
- e. Amygdales mastoïdiennes
- f. Amygdales tubaires (dans la fosse de Rosenmüller)

75. Dans la mastoïdite aiguë

- a. Le traitement consiste en une stapédotomie b. Le traitement consiste en une antibiothérapie
- c. Le traitement consiste en une chirurgie reconstructive avec restauration de l'audition par tympanoplastie d. Le traitement consiste en une myringotomie e. Le traitement consiste en une mastoïdectomie

76. Les abcès liés à une infection mastoïdienne sont :

- a. Bezold
- b. Pétrosite
- c. Zygomatique d. Cellulite orbitaire e. Postauriculaire

77. Les symptômes de l'amygdalite aiguë sont :

- a. Respiration buccale
- b. Difficulté à avaler
- c. Fièvre
- d. Mal de gorge
- e. Mal d'oreille

78. L'hypopharynx est cliniquement subdivisé en

- a. Corde vocale
- b. Pli ventriculaire
- c. Sinus piriforme d. Zone post-cricoïde
- e. Paroi pharyngée postérieure

79. Les tumeurs bénignes du larynx sont

- a. Chondrome
- b. Ostéome
- c. Hémangiome d. Botriomycome e. Papillome

80. Les lésions congénitales du larynx sont

- a. Laryngomalacie
- b. Atrésie des choanes
- c. Rebord laryngé d. Fente palatine e. Laryngocèle

81. Le sinus maxillaire

- a. S'ouvre dans le méat supérieur b. Son innervation provient du IXe nerf crânien
- c. C'est le plus grand sinus d. S'ouvre dans le méat supérieur e. A une capacité de 5 ml

82. Les symptômes de la rhinite vasomotrice ne sont **PAS**

a. Obstruction nasale

b. Bronchospasme c.

Écoulement post-nasal

d. Respiration

sifflante e. Prurit oculaire

83. Nodules vocaux

a. Sont considérées comme des réactions tissulaires

tumorales. b. Plus fréquentes chez les patients

de sexe masculin. c. Ne sont pas favorisées par une

surcharge vocale. d. Sont traitées

chirurgicalement. e. Le repos de la voix est recommandé.

84. Les complications d'un traumatisme laryngotrachéal sont représentées par : a.

Perte du goût b.

Périchondrite/abcès laryngé c. Paralyse des

cordes vocales d. Sténose

laryngée e. Hyposmie 85. Un

traumatisme

laryngotrachéal peut être représenté par

a. Hématome et œdème

b. Othématome

c. Luxation de l'articulation crico-aryténoïdienne

d. Fractures des os hyoïdes, des cartilages thyroïdiens et cricoïdes e. Fractures

des anneaux trachéaux supérieurs

86. Voici les complications intratemporales de l'otite moyenne

a. Abscessus sous-dural

b. Paralyse faciale c.

Mastoidite

d. Méningite e.

Pétrosite

87. *Les structures de la paroi oropharyngée sont les suivantes, à **une exception près** : a. La muqueuse

b. Aponévrose pharyngée c. Fascia

musculaire

d. Fascia bucco-pharyngé e. Périoste